MARRAKECH
جامعة القاضي عياض
UNIVERSITÉ CADI AYYAD

Guide du Résident 2017

كليـــــة الـطب
و الصيدلة - مراكش

FACULTÉ DE MÉDECINE
ET DE PHARMACIE - MARRAKECH



Guide du Résident
2017

Le mot du Doyen

Vous venez de réussir au concours de résidanat et je vous en félicite.
Pendant votre résidanat, vous aurez des droits et des devoirs dont la base réglementaire vous sera rappelée.
A côté de votre établissement universitaire, vous allez découvrir de nouveaux partenaires à l'hôpital qui vous accompagneront tout au long de votre cursus.
Ce document a pour ambition de vous donner l'essentiel des informations indispensables au bon déroulement de votre résidanat.
Le résident est un praticien en formation spécialisée. Il consacre la totalité de son temps à ses activités médicales et à sa formation. Il assure des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève.
Le résident reçoit une formation théorique et pratique sur le lieu d'affectation, en plus de la formation universitaire. Le résident est soumis au règlement intérieur des établissements dans lesquels il exerce son activité.
Ce guide a été établi pour accompagner les médecins en cours de formation qui désirent se spécialiser dans une branche médicale, chirurgicale ou biologique et les éclairer tout au long de leurs parcours, depuis les étapes avant l'admission jusqu'à la fin de leurs cursus. Il explique le système de résidanat qui est la préparation du Diplôme de Spécialité Médicale (DSM) en Médecine, chirurgie et Biologie.
Ce guide rassemble toutes les informations pratiques susceptibles de vous être utiles durant la durée de votre cursus. Ensemble, nous mettrons notre ambition au service de l'amélioration de la qualité des soins, d'une plus grande efficacité des équipes et d'un meilleur fonctionnement de l'établissement. Notre mission restera toujours d'accueillir et de soigner tous les patients, à tout moment et dans le respect mutuel.
La formation des médecins spécialistes doit se développer régulièrement pour améliorer les indicateurs sanitaires de notre pays et atteindre les objectifs de développement du millénaire. La formation théorique devra faire le meilleur usage des nouvelles technologies pour la formation à distance. La formation pratique devra se faire dans les services complémentaires pour la spécialité choisie. Des partenariats doivent être trouvés pour permettre des formations dans des structures sanitaires nationales ou internationales, dans des domaines de pointe. Nous allons travailler pour activer le collège de spécialité pour établir un programme de la qualité de prise en charge des résidants en pensant à leur cursus (révision des programmes) et aux stages de perfectionnement.
Le collège de spécialité a pour tâche :

- Etablir et réactualiser le cursus de formation des spécialistes
- Etablir un guide de l'internat et du résidanat
- Se concerter à propos des affaires concernant le résidanat
- Elaborer toute proposition tendant vers l'amélioration de l'encadrement des médecins résidants
- Valider les stages

Mohammed Bouskraoui
Doyen de la FMPM

Sommaire

A. Comment s'inscrire au diplôme de spécialité ? ***3***

B. Procédures administratives après le choix de spécialité : ***5***

1. Dossier de recrutement 5
2. Dossier d'intégration des résidents dans la santé publique 6
3. Changement de spécialité 6
4. Devoirs et droits 7
5. L'accueil des résidents 7
6. Congés 7
7. Responsabilité 8
8. Assurances 9
9. Formation 10
10. Stages 10
11. Evaluation 12
12. Gardes et astreintes 12
13. Accidents du travail 13
14. L'accès à l'information 13
15. Communication 13
16. Collaboration 13
17. Gestion 14
18. Promotion de la santé 14
19. Érudition 14
20. Professionnalisme 14
21. Ethique et déontologie 15

Annexe 1 : Liste des spécialités médicales 16
Annexe 2 : Liste des responsables des spécialités 17

A. Comment s'inscrire au diplôme de spécialité ?

Pour s'inscrire à une spécialité, l'étudiant doit avoir la qualification de résident, cette qualification peut être obtenue par deux voies :

1. 1ère voie : Résident sur titre

Ce sont les internes du centre hospitalier universitaire (CHU) ayant validé les 2 ans d'internat et ayant réussit aux examens cliniques.

a. Comment devenir interne du CHU ?

Ce sont les étudiants ayant validé leurs 5 années d'études médicales (examens et stages hospitaliers) qui deviennent internes du CHU après avoir réussit au concours d'internat.

Ce concours est organisé chaque année par la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech (FMPM) dans des dates déterminées et qui sont annoncées au plus tard un mois avant le concours. L'avis de recrutement se fait par affichage au décanat et dans le hall de la FMPM (BP 7010 Sidi Abbad Marrakech Maroc , Tel : +212 5 24 33 98 98, Fax: +212 5 24 43 70 31,decanatfmpm@uca.ma), ainsi que sur le site internet (http://www.uca.ma/fmpm).

Le nombre de postes est déterminé selon les besoins du CHU et communiqué par le Ministère de la Santé.

Après avoir déposé leurs dossiers de candidature dans le bureau du 2ème cycle directement ou par voie postale , le candidat est convoqué pour passer le concours qui se déroule dans la FMPM sur deux étapes :

1ère étape : l'épreuve d'admissibilité où le contrôle de connaissance concerne l'anatomie, la physiologie, la médecine et la chirurgie, cette épreuve se passe en deux jours. Après avoir passé cette première épreuve, les candidats ayant réussit ont le droit de passer à la deuxième étape. Les résultats sont affichés en général dans les 48h au hall de la faculté.

2ème étape : L'épreuve d'admission où le contrôle de connaissance concerne les urgences médicale et chirurgicale, cette épreuve se passe en un jour. Après avoir réussit cette dernière épreuve, l'étudiant devient alors interne du CHU et sera convoqué pour commencer son cursus d'internat par la faculté en coordination avec l'association des médecins internes de Marrakech dont il devient membre.

Dans ce cursus qui dure deux ans l'interne doit passer et valider 4 stages, d'une durée de six mois chacun dans différentes spécialités (Médecine, Chirurgie, Pédiatrie, Gynécologie) et doit assurer les gardes aux urgences du CHU, cette répartition se fait selon les besoins du CHU, et le choix des services selon l'ordre d'ancienneté et de mérite dans des réunions qu'organise l'association des médecins internes ou AMIMA.

En plus de ces stages hospitaliers, l'interne est amené à réussir comme tout étudiant de 7ème année des examens cliniques et à soutenir une thèse de doctorat.

b. Qu'est ce qui se passe après les deux ans d'internats : Choix des postes de spécialité :

Après avoir validé les deux ans d'internat, chacun des internes de la même promotion émet des

propositions pour le choix des éventuelles spécialités qu'il désire dans une réunion organisée par l'association des internes, ces pré-choix sont communiqués au Doyen de la faculté qui les prend en considération en coordination avec le ministère pour satisfaire les demandes et ouvrir les postes en fonction des besoins.
Deux types de postes existent : postes bénévoles « le résident n'est pas amené à s'engager avec les services publics » et postes contractuels « le résident est amené à signer un contrat d'engagement de huit ans avec les services publics ».
Une fois les postes ouverts, les internes sont tenus de faire un choix définitif de spécialité du type de poste voulu et signer un contrat d'engagement qui lui confère la qualité de résident sur titre et le début de sa formation spécialisée.

2. 2ème voie : Résident sur concours

Ce sont les médecins ayant réussit au concours de résidanat.

a. Comment devenir résident au CHU ?

Sur demande de ministère de tutelle, le concours de résidanat est organisé chaque année par la FMPM dans des dates déterminées qui sont annoncées au plus tard un mois avant le concours. L'avis de recrutement se fait par affichage au décanat et dans le hall de la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech, ainsi que sur le site internet (http://www.fmpm.ucam.ac.ma/). Le nombre de poste et le type de poste ouvert est déterminé selon les besoins du ministère de la santé et la capacité d'accueil des services formateurs.
Peuvent devenir résident, tout les docteurs en médecine ayant réussit au concours de résidanat, ce qui leurs confère la possibilité d'inscription en 1ère année en vue de la préparation du diplôme de spécialité médicale, chirurgicale ou biologique.
Avant de passer le concours, le candidat doit d'abord choisir le type de spécialité pour laquelle il opte, (médicale, chirurgicale ou biologique), chose qui va conditionner les coefficients des modules qu'il va passer au concours. Il doit le mentionner dans la demande manuscrite qu'il doit déposer avec le reste du dossier en vue de l'inscription au concours.
La demande manuscrite doit comporter aussi :

- Nom, prénom et adresse du candidat
- Date et lieu de naissance

Elle doit être accompagnée des documents suivants :

- Une photocopie légalisée du diplôme de doctorat en médecine
- Titres hospitaliers
- Un relevé de notes de la 1ère à la 5ème année et des épreuves cliniques
- Une attestation d'équivalence pour les diplômes étrangers
- Deux enveloppes timbrées portant l'adresse du candidat
- Un extrait d'acte de naissance datant de moins de trois mois
- Une photocopie certifiée conforme de la carte d'identité nationale
- Une autorisation de participation au concours délivrée par le ministère de la santé pour les médecins fonctionnaires.

Ce dossier est déposé à la faculté de médecine, au bureau du 3ème cycle, soit directement ou par voie postale à l'adresse de la faculté.
Le candidat est convoqué pour passer le concours qui se déroule dans la FMPM sur deux étapes comme pour le concours d'internat.
Epreuves du concours :

Epreuve	Durée
Anatomie	2h
Biologie	2h
Pathologie médicale	2h
Pathologie chirurgicale	2h
Epreuve d'admission	
Urgences et conduites à tenir médicales	2h
Urgences et conduites à tenir chirurgicales	2h

La liste des questions du programme de résidanat est disponible mais pouvant être sujette à des réactualisations, il faudrait alors se renseigner auprès du service de 3ème cycle pour avoir la liste exhaustive.

b. Choix des postes de spécialités:

Après avoir réussit au concours de résidanat; chacun des candidats choisit un poste de spécialité et le type d'engagement « bénévole ou contractuel » parmi les postes proposés par le ministère de la santé, le choix de la spécialité se fait chronologiquement selon l'ordre de mérite suivant la discipline choisie auparavant.
Une fois le choix fait et après avoir signé le contrat d'engagement, le médecin bénéficie du titre de résident.

B. Procédures administratives après le choix de spécialité

1. Dossier de recrutement :

Une fois le choix fait et l'engagement signé, le résident « sur titre comme sur concours », rejoint le service formateur, après avoir reçu une note de service, provenant du décanat et de la direction du CHU, invitant le résident à rejoindre son poste.
Le résident se doit alors de rejoindre son service, de signer la prise du service «document qu'il va récupérer au service de 3ème cycle»
La prise de service sera aussi signée par le chef de service, le directeur du CHU et le doyen.
Il est amené à constituer un dossier, qu'il va déposer à la direction du CHU de Marrakech, service de gestion du personnel [Direction générale du CHU Mohammed VI - BP : 2360 Avenue Ibn Sina Ammerchich – Marrakech, Tél. : +212 (0)5 24 300 700 / 701 / 629 - Fax : +212 (0)5 24 300 631)]

Pièces à fournir pour la constitution du dossier de recrutement du résident :
- 2 photos d'identité
- 3 photocopies légalisées de la carte nationale
- 2 extraits d'acte de naissance
- 2 engagements de servir l'administration (pour les contractuels) « à récupérer au service du personnel du CHU, et à légaliser après l'avoir signé »
- 1 compte rendu de prise de service
- 2 fiches de renseignements « à remplir au service du personnel du CHU »
- Copie légalisée du diplôme de doctorat
- 1 chèque barré

Après l'avoir déposé, le résident peut bénéficier de son titre et être en exercice légal . Ce dossier est aussi indispensable pour recevoir les rémunérations, les indemnisations et constituer un dossier d'assurance maladie.

2. Dossier d'intégration des résidents dans la santé publique :

- Avant l'an 2013, l'intégration à la santé publique ne concerne que les résidents contractuels ayant validé la deuxième année de résidanat.

- A partir de 2013, selon les acquis ministériels, cette intégration va intéresser les résidents contractuels dès leur 1ère année.

En attendant l'application de ce décret, nous vous exposons à titre indicatif les pièces à fournir pour la constitution du dossier d'intégration .

Pièces à fournir pour la constitution du dossier d'intégration dans le cadre du médecin de 1er grade:

- 4 photocopies légalisées du diplôme de doctorat
- 4 exemplaires d'extraits d'acte de naissance datés de moins 3 mois
- 2 extrait du casier judiciaire ou fiche anthropométrique datée de moins de 3 mois
- 4 photos d'identité
- 4 exemplaires de photocopies légalisées de la carte nationale
- 4 attestations de réussite
- 2 Certificats de la commission médicale
- 4 Compte-rendus de prise de service
- 2 Chèques barrés.
- 3 Contrats d'engagement

Ce dossier est déposé au bureau de gestion du personnel, à la direction du CHU, et sera par leurs biais communiqué au ministère de la santé.

3. Changement de spécialité :

Après choix de spécialité et signature de l'engagement, aucune demande de changement de spécialité ne sera acceptée. Ainsi pour tout désir de changement de spécialité, le résidant est obligé de repasser le concours de résidanat et choisir une autre spécialité selon son classement dans ce deuxième concours.

Néanmoins, à titre tout à fait exceptionnel et pour des considérations strictement pédagogiques, la demande de changement de spécialité peut être recevable durant le premier trimestre du résidanat et seulement à l'intérieur du groupe de spécialité auquel appartient le requérant.
Auquel cas, elle doit être dûment motivée et assortie de l'accord des chefs de services formateurs, du Directeur du Centre Hospitalier et du Doyen de la Faculté concernés.

4. Devoirs et droits :

- Le résident est un praticien en formation spécialisée. Il consacre la totalité de son temps à ses activités médicales et à sa formation.
- Hormis les absences légales prévues par le statut (congé annuel, maternité, mariage, mise en disponibilité), aucune interruption des fonctions n'est possible au cours du semestre.
- Au cours de sa formation, le résidant n'a pas le droit d'exercer en privé.

Obligations :

- Toutes les obligations normales du jour : 11 demi- journées par semaine
- Participation au service de garde et d'astreinte.
- Soumission au règlement intérieur de l'établissement.
- Les résidents qui n'ont pas reçu une série vaccinale complète contre l'hépatite B devront débuter et compléter leur vaccination.

Nature des fonctions :

- Fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du chef de service
- Formation théorique et pratique nécessaire à l'exercice des fonctions sur le lieu de l'affectation.
- Encadrement des externes et des internes, par délégation et sous la tutelle du chef de service.
- Participation à des campagnes sanitaires par délégation et sous la tutelle du chef de service.

Rémunération :

L'établissement d'affectation assure la rémunération.

- Résidents bénévoles : 3000dhs , net, mensuels
- Résidents contractuels :
    - o Avant l'intégration : 7000 dhs, net, mensuel
    - o Après l'intégration : 8930dhs , net mensuel
- Indemnités de garde : selon le nouveau décret ministériel.
    - o 276 dhs pour les gardes résidentielles
    - o 69 dhs pour les gardes d'astreintes

5. L'accueil des résidents :

Une rencontre d'accueil pour les nouveaux résidents est prévue au début de chacune des années. Le directeur de programme, de même que tous les résidents actuels du programme, participent à cette rencontre. La rencontre permet, entre autres, de présenter le présent guide ainsi que le déroulement du résidanat.

Lors de chaque stage, c'est le responsable du thème de stage qui accueille le résident et qui s'occupe de son organisation physique dans le milieu de stage (bureau du travail, ordinateur et autre matériel).

6. Congés :

Ils sont gérés par l'établissement d'affectation. Les résidents ne peuvent s'absenter, sous peine de sanctions disciplinaires, de leur lieu de stage qu'au titre des congés réglementaires et des

disponibilités), aucune interruption des fonctions n'est possible au cours du semestre et des obligations liées à leur formation.

Chaque congé annuel doit faire l'objet d'une demande d'autorisation signée par le chef de service et transmise à la Direction de l'établissement. Pris en une seule fois, le congé ne peut excéder 22 jours ouvrables consécutifs. Les jours de congés annuels doivent être pris par année universitaire. Les congés annuels sont accordés par l'établissement d'affectation, après avis du chef de service.

- Annuel :

Le résidant a le droit après avoir passé 12 mois de service, de demander chaque année un congé payé fait de 22 jours ouvrables. Il est tenu de consommer son congé durant l'année correspondante.

La durée du congé ouvrable ne peut être répartie sur plus de deux fois, les congés annuels sont accordés par l'établissement d'affectation, dans la limite des obligations de service.

- Maternité :

Les résidentes enceintes ont le droit de bénéficier à partir du dernier mois de grossesse d'un congé de maternité d'une durée de 14 semaines qui peut être prolongé à 22 semaines si un état pathologique résultant de la grossesse ou des couches est attesté. Pour cela, elles sont tenues de ramener un certificat médical, attestant de l'âge de grossesse et après l'accouchement d'un certificat de naissance, qu'elles vont déposer accompagné de la demande de congé à la direction du CHU.

- Mariage :

Les résidents qui se sont mariés après le recrutement ont le droit à un congé de mariage de 4 jours. Pour en bénéficier, ils sont tenus de remplir la demande et de l'accompagner de l'acte de mariage.

- Maladie :

Les résidants peuvent bénéficier du congé de maladie sur présentation d'un certificat médical au chef de service. Si l'absence dépasse 3 jours, une contre-visite peut être demandée.

En cas de congé de maladie de longue durée ≥ 6 mois, cette période n'est pas prise en considération pour le calcul de la durée effective de l'internat et du résidanat

8. Responsabilité :

- Responsabilité civile :

L'établissement prend à sa charge, par l'intermédiaire de son assurance, les conséquences financières des actes qui ont été réalisés à l'encontre de patients, hormis les cas rarissimes où la faute est commise volontairement (vol, coups et blessures...) ou bien lorsque la faute est considérée comme inexcusable, aberrante au regard de l'exercice normal de la profession (ex : décès d'un

patient suite au non déplacement d'un médecin en astreinte, malgré de nombreux appels). La faute médicale « civile » peut aussi être une faute d'humanisme : absence de consentement du patient à l'acte médical, prise de risques disproportionnée en l'absence de nécessité médicale, défaut d'information sur les risques de l'intervention ou les résultats de l'intervention.

- Responsabilité pénale :

Elle est strictement personnelle. Les types d'infractions pouvant mettre en cause un médecin sont l'homicide involontaire, l'atteinte involontaire à l'intégrité d'autrui (causée par imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement), la mise en danger d'autrui, la non assistance à personne en péril, la violation du secret professionnel...

Dans les actions contentieuses, le rôle du dossier médical est considérable : il peut certes représenter pour le plaignant le moyen d'obtenir réparation lorsque ses droits ne sont pas respectés; mais c'est aussi, pour le professionnel, un moyen de prouver l'absence de faute et de préserver la qualité de la communication avec le patient.

9. Assurances :

Les maladies professionnelles sont couvertes par une assurance contractée par le CHU concerné. Pour en bénéficier, l'accident doit être déclaré dans les 48 h par un formulaire signé par le chef de service et présenté au service de médecine de travail et à la direction de l'hôpital.

Les maladies et accidents n'entraînant pas d'incapacité permanente sont soignés gratuitement dans les centres hospitaliers. Pour en bénéficier, le résidant est tenu de ramener une copie de sa carte de résident, une copie de la carte nationale, une copie de l'examen ou bilan demandé,ces pièces vont être déposées au secrétariat de la direction de l'hôpital pour obtenir la gratuité.

Après l'intégration à la fonction publique, le résident est systématiquement inscrit à la Caisse nationale des organismes de prévoyance (CNOPS), mais pour pouvoir bénéficier du régime de couverture, il est amené à s'y inscrire.

Pièces à fournir : à titre indicatif

- Un formulaire d'information rempli et signé par l'employeur « téléchargeable sur le site de la CNOPS »
- Une copie de la carte nationale
- Deux photos d'identité
- Etat d'engagement ou bulletin de paie
- Justificatifs supplémentaires notamment de la situation familiale (certificat de mariage, acte de naissance…)

Ces documents sont envoyés ou déposés dans les centres suivants :

- Délégation régionale de la caisse (Tel : 0524 301 885, 0524 291 609, 052 4301 885)
- Direction du CHU (service de gestion du personnel)

10. Formation :

Formation théorique :

- Programme théorique spécifique pour chaque spécialité
- Préparation et présentation des cours selon une liste établie de façon semestrielle
- Participation aux séances de bibliographie
- Participation à tous les staffs du service ou auxquels le service participe
- Participation aux différentes manifestations nationales ou internationales par des communications orales ou affichées
- Participation à des publications du service

Formation pratique :

- Participation à toutes les activités du service (visite , consultation , gardes , …..)
- Cursus dans d'autres services : le résidant pourra être amené à faire des cursus de formation complémentaires dans d'autres services. Les modalités de ces cursus (objectifs, durées, moment et évaluation) seront précisées par les services d'origine et d'accueil.

Tout stage dans d'autres établissements nécessite l'accord du chef de service. La durée, le contenu des enseignements théoriques et la nature des stages pratiques de chaque spécialité constituent la maquette. Son respect est obligatoire et conditionne l'obtention du diplôme.

Chaque diplôme est placé sous la responsabilité d'un coordonnateur chargé d'organiser les enseignements théorique et pratique.

11. Stages :

Afin que les résidents puissent réaliser leur stage de manière la plus autonome et éclairée possible, diverses informations institutionnelles portant sur des politiques ou procédures spécifiques leurs sont délivrées. Ces informations concernent en particulier :

- La politique qualité et la sécurité des soins de l'établissement.
- Les principaux logiciels utilisés dans l'établissement (dossier médical, prescriptions d'actes, commandes, codage,...)
- Les vigilances, les procédures de gestion des risques associées ainsi que les procédures de déclaration des évènements indésirables graves
- Les politiques de bon usage des prescriptions et le circuit du médicament
- Les modalités de représentation et de participation des usagers au sein de l'établissement ainsi que les conditions de traitement des réclamations et plaintes
- La prévention des risques d'accidents ou de maladies professionnelles
- Les protocoles internes de conduite à tenir en cas d'urgence vitale

Un accueil, organisé par le responsable de service, est prévu afin de présenter l'organisation des structures (unités, services, cliniques, pôle), les organigrammes médical et paramédical, le projet de service, les modalités organisationnelles, les procédures de fonctionnement médicales, les temps de coordination entre professionnels, et d'une manière générale, tout ce qui présente une spécificité médicale ou technique particulière par rapport aux informations reçues dans le cadre de l'information générale à la prise de fonction.

La formalisation, dans le cadre d'un livret de stage, des objectifs du stage hospitalier, des missions confiées au résident et de la participation à la permanence de soins doit fortement contribuer à la mise en valeur et à l'amélioration continue de la formation reçue dans l'établissement, en conformité avec le projet pédagogique défini par le coordonnateur universitaire.

Les résidents s'engagent à :

- participer de manière active à leur formation
- respecter les obligations professionnelles et déontologiques liées à l'exercice médical public
- respecter le règlement intérieur de l'établissement
- participer aux temps d'accueil et d'intégration organisés à leur intention
- participer à la vie collective et aux instances de l'établissement au sein desquelles ils sont représentés
- réaliser leurs obligations de service
- respecter le matériel, les équipements et les locaux d'exercice professionnel, de repos ou de détente, mis à leur disposition
- participer à la permanence de soins au sein de l'établissement

L'avis de validation du stage :

Cette décision administrative est dévolue au chef de service. Elle obéit aux mêmes règles que celles définies pour les semestres hospitaliers. Elle repose sur :

- l'autonomie développée au cours du stage,
- l'implication et la motivation de résident dans son stage.
- l'assiduité de résident auprès de ses maîtres de stage. En particulier, un stage d'une durée < à 4 mois ne peut être validé. Le contrôle des absences sur les lieux de stage relève du chef de service.
- le jugement établi par l'ensemble des responsables de stage sur le déroulement du stage, en tenant compte des indicateurs suivants :
  - o la réalisation des objectifs d'apprentissage de résident,
  - o le développement de compétences professionnelles en référence aux rôles du médecin généraliste .
  - o la qualité du travail personnel de résident dans son portfolio,
  - o le comportement du résident dans sa relation thérapeutique avec le patient

Le résident est un médecin en formation.

Il appartient à un corps professionnel reconnu et bénéficiant d'une forte identité. Ce moment de la vie professionnelle voué à l'acquisition des connaissances renforce son image de compétence. Le résident est aussi un médecin formateur, dont l'étudiant observe les comportements envers les patients et l'équipe soignante. Il faut qu'il prenne conscience de ses responsabilités de maître d'apprentissage. Accueillir l'étudiant, l'aider à comprendre son rôle, répondre à ses questions et être attentif à ses difficultés donneront un autre sens à sa fonction de résident.

12. Evaluation :

L'évaluation comporte deux volets :

- Une évaluation des stages et autres activités d'apprentissage, notamment les cours théoriques, ateliers, séminaires, laboratoires, etc.
- Une évaluation longitudinale qui porte sur l'acquisition de l'ensemble des compétences requises pour votre niveau de formation.

Vous êtes soumis à l'évaluation non seulement de vos connaissances, mais de vos attitudes et de vos habiletés, ainsi qu'à l'évaluation de votre comportement en milieu professionnel.

L'évaluation peut se faire sous forme d'observation, de travaux ou d'examens. Elle comporte également des données issues de personnes (professeurs, professionnels de la santé, étudiants et patients) qui ont été en contact avec vous.

C'est une évaluation annuelle. Pour pouvoir passer d'une année à la suivante le résident doit valider le stage et réussir l'examen de fin d'année. La validation de stage repose sur :

- La présence
- L'intégration dans l'équipe
- Le degré d'auto-formation
- Le degré de responsabilité
- La qualité du raisonnement clinique
- La validation des objectifs spécifiques pour chaque spécialité correspondant au semestre à validé
- L'acquisition des compétences spécifiques pour chaque spécialité correspondant au semestre à validé
- L'examen annuel : Après avoir validé le stage le résident est autorisé à passer l'examen . Cet examen est organisé par la faculté à la fin de la 1ère année et à la fin de la dernière année alors que pour les autres années, il est organisé par le service responsable.

Les modalités de l'examen selon les textes :

- Evaluation des titres et travaux
- Questions écrites
- Observation

A noter que lors de l'examen de fin de formation, des spécialités peuvent exiger des mémoires de fin d'étude.

13. Gardes et astreintes :

Le résident participe obligatoirement au service de gardes et astreintes. Il peut assurer une participation supérieure au service de garde. A l'issue de chaque garde de nuit, le résident est en position de repos de sécurité, constitué par une interruption totale de l'activité hospitalière et universitaire pendant au moins 11 heures. Les missions de résident en garde sont :

- Examen clinique des patients
- Les premières décisions diagnostiques et thérapeutiques et l'établissement du dossier médical ;

Ces missions s'effectuent sous la supervision, les conseils et la responsabilité du médecin de permanence qui reste joignable pendant toute la durée de la garde.

14. Accidents du travail :

L'employeur est tenu d'en faire la déclaration écrite dans les 48 heures suivant le jour où il est intervenu. Le respect de ce délai est impératif.

En cas d'accident d'exposition au sang, une déclaration de cet accident doit être fait dans les 24h auprès de la Direction des affaires médicales. Vous devez vous munir :

- d'un certificat médical (en précisant le risque de séroconversion)
- d'une déclaration d'accident signé par la victime et le responsable du service

Vous devez effectuer une prise de sang à J0 et poursuivre le suivi à 1 mois et à 3 mois. Ces examens peuvent se faire dans le service de la médecine du travail.

15. L'accès à l'information :

Le CHU dispose d'une bibliothèque électronique très complète qui permet notamment :

- de consulter les rubriques comme Clinical Key
- d'accéder à plusieurs bases de données comme Medline, Vidal et CISMeF (sites et documents médicaux francophones)

16. Communication :

Le résident sera en mesure de :

- Communiquer verbalement de manière appropriée et efficace avec les patients, les familles et les collègues
- Identifier les enjeux socio-culturels qui influencent les patients, l'évolution de leur maladie et leurs soins
- Établir une relation thérapeutique avec les patients
- Communiquer par écrit de manière appropriée et concise le contenu de l'histoire, l'examen, le diagnostic et le traitement dans les dossiers des patients
- Transmettre l'information de manière adéquate et concise aux collègues sur les cas de patients
- Déclarer les cas de maladies à déclaration obligatoire
- Démontrer des habiletés d'écoute appropriées à la situation clinique
- Obtenir un consentement approprié en fonction des besoins spécifiques des patients
- Partager ses préoccupations relatives à la médecine communautaire avec les collègues

17. Collaboration :

Le résident sera en mesure de :

- Participer et contribuer de manière constructive à une équipe multidisciplinaire
- Collaborer avec les collègues d'autres spécialités médicales dans la prise en charge de patients
- Identifier et contacter les ressources de la communauté qui peuvent contribuer à la prise en charge des patients

18. Gestion :

Le résident sera en mesure de :

- Organiser efficacement son travail clinique
- Manifester un leadership dans la prise en charge des patients
- Utiliser de manière appropriée les technologies de l'information
- Rédiger les formulaires nécessaires (certificat de décès, etc.)
- Assurer les liens avec les ressources de première ligne (ex. : maintien à domicile, médecin de famille, etc.)
- Coordonner la prise en charge des patients en fonction de l'organisation des services de première ligne
- Utiliser les ressources cliniques de manière efficiente et efficace
- Poser un regard critique sur l'organisation et la prestation des services de santé

19. Promotion de la santé :

Le résident sera en mesure de :

- Reconnaître les situations où il faut faire un plaidoyer pour la santé des patients ou des familles (ex. protection de la santé des travailleurs)
- Élargir son approche afin de dépasser la demande initiale et répondre aux situations où il faut agir en défenseur de la santé des patients ou des familles (ex. : tabagisme secondaire)
- Identifier les besoins et les occasions où il faudrait agir de manière favorable à la santé des individus et de la communauté (ex. logement insalubre constaté lors de visite à domicile)

20. Érudition :

Le résident sera en mesure de :

- Analyser l'application des preuves scientifiques dans la pratique clinique préventive, porter un jugement sur l'évaluation de ces pratiques et l'évolution des connaissances dans ce domaine
- Démontrer de la motivation et de l'autonomie dans la consultation de la littérature scientifique
- Trouver et évaluer les données pertinentes de la littérature et les appliquer à la prise en charge des patients
- Connaître les sources les plus importantes de lignes directrices et autres avis concernant les soins de santé
- Éduquer ses patients
- Contribuer à la formation des étudiants en médecine
- Faire une présentation scientifique sur un sujet clinique en abordant les préoccupations de santé publique
- Analyser des articles scientifiques de manière critique

21. Professionnalisme :

Le résident sera en mesure de :

- Démontrer un sens aigu des responsabilités

- Respecter les patients, les membres de leurs familles, le personnel, les collègues et agir avec honnêteté dans ses relations avec toutes ces personnes
- Manifester de l'empathie envers ses patients
- Identifier les enjeux éthiques et légaux qui se présentent lors des situations cliniques
- Appliquer les principes éthiques dans la prise en charge des patients
- Reconnaître ses limites et poser un regard critique sur ses actions
- Intégrer le feedback reçu pour améliorer sa pratique

22. Ethique et déontologie :

L'exercice d'une profession soignante, et singulièrement de la médecine, ne peut se concevoir sans un comportement et une réflexion éthiques (morale), personnels et collectifs.

La pratique quotidienne de résident sera questionnée par le «bon», le «juste», la «bonne décision», la «bonne voie». Vos aînés seront à vos côtés pour vous aider à bien répondre, mais surtout, interrogent le «code de déontologie médicale».

Il dit aussi que le respect de la personne et de sa dignité, le secret médical, la confraternité, le respect des autres les professionnels de santé seront, pour vous, autant de «devoirs», pour mériter les «droits» qui seront accordés à l'interne.

Les résidents s'engagent à :

- Répondre à leurs devoirs de bonne utilisation et de respect des locaux et des matériels qui sont mis à leur disposition,
- Respecter le secret médical et la confidentialité,
- Veiller à la qualité de l'accueil et de l'écoute vis-à-vis des patients et de leurs proches,
- Respecter ses collègues de travail et l'ensemble du personnel hospitalier,

Annexe 1 : Liste des spécialités médicales

Décret 2-92-183,B.O. 4207 du 16/6/1993 (Complété par l'arrêté ministériel 1315-99 du 21/10/1999)
ART.2.- Les spécialités médicales ainsi que leurs durées

Spécialités de Médecine :	Durée des études
- Médecine interne	5 ans
- Cardiologie	4 ans
- Dermatologie	4 ans
- Endocrinologie et maladies métaboliques	4 ans
- Gastro-entérologie	4 ans
- Néphrologie	4 ans
- Pédiatrie	4 ans
- Psychiatrie	4 ans
- Neurologie	4 ans
- Pneumologie	4 ans
- Radiologie	4 ans
- Rhumatologie	4 ans
- Radiothérapie	4 ans
- Réanimation médicale	4 ans
- Anesthésie réanimation	4 ans
- Médecine Communautaire (ou médecine préventive, santé publique et hygiène)	4 ans
- Médecine légale	4 ans
- Oncologie médicale	4 ans
- Maladies infectieuses	4 ans
- Hématologie clinique	4 ans
- Epidémiologie clinique	4 ans
- Hygiène hospitalière	4 ans
- Informatique médicale	4 ans
- Médecine du travail	3 ans
- Médecine du sport	3 ans
- Médecine Physique et réadaptation fonctionnelle	4 ans
- Médecine Nucléaire	4 ans
- Médecine D'urgence et de catastrophe	5 ans
- pédopsychiatrie	4 ans
SPECIALITE DE CHIRURGIE :	
- Chirurgie générale	5 ans
- Chirurgie pédiatrique	5 ans
- Gynécologie obstétrique	5 ans
- Neurochirurgie	5 ans
- Ophtalmologie	5 ans
- Oto-rhino-laryngologie	5 ans
- Urologie	5 ans
- Traumatologie orthopédique	5 ans
- Chirurgie cancérologique	5 ans
- Chirurgie thoracique	5 ans
- Chirurgie cardio-vasculaire	5 ans
- Stomatologie et chirurgie maxillo-faciale	5 ans
- Chirurgie réparatrice et plastique	5 ans
- Chirurgie vasculaire péripherique	5 ans
SPECIALITE DE BIOLOGIE :	
- Anatomie	4 ans
- Anatomie pathologique	4 ans
- Physiologie	4 ans
- Biophysique	4 ans
- Biochimie	4 ans
- Parasitologie	4 ans
- Histologie –embryologie –cyto -génétique	4 ans
- Microbiologie	4 ans
- Hématologie	4 ans
- Immunologie	4 ans
- Mycologie	4 ans
- Génétique	4 ans
- Virologie	4 ans
- Pharmacologie	4 ans
- Toxicologie	4 ans
- Biologie médicale	4 ans

Annexe 2 : Liste des directeurs de spécialités

N°	NOM & PRENOM	SERVICE
1	Pr. Said AIT BENALI	Neurochirurgie
2	Pr. Mohamed SBIHI	Pédiatrie
3	Pr. Khadija KRATI	Gastro-entérologie
4	Pr. Abderraouf SOUMMANI	Gynécologie-Obstétrique
5	Pr. Abdelaziz RAJI	ORL
6	Pr Halim SAIDI	Traumato-orthopédie
7	Pr. Ag. Hanane RAIS	Anatomie Pathologique
8	Pr. Najib KISSANI	Neurologie
9	Pr. Ismail SARF	Urologie
10	Pr. Abdeljalil MOUTAOUAKIL	Ophtalmologie
11	Pr. Benasser FINECH	Chirurgie Viscérale
12	Pr. Fatima ASRI	Psychiatrie
13	Pr. Said AMAL	Dermatologie
14	Pr. Lamia ESSAADOUNI	Médecine Interne
15	Pr. Ag. Nabila SORAA	Analyses Biologiques
16	Pr. Drissi BOUMZEBRA	Chirurgie Cardio-Vasculaire
17	Pr. Nadia MANSOURI	Chirurgie Maxillo-faciale et Stomatologie
18	Pr. Mohamed Abdenasser SAMKAOUI	Anesthésie Réanimation
19	Pr. Lahoucine MAHMAL	Hématologie Clinique et Oncologie Médicale
20	Pr. Ag. Nawal EL ANSARI	Endocrinologie et Maladies Métaboliques
21	Pr. Ag. Imane EL BOUCHTI	Rhumatologie
22	Pr. Mohamed OULAD SAIAD	Chirurgie Pédiatrique
23	Pr. Saloua ETTALBI	Chirurgie Plastique et réparatrice
24	Pr. Mustapha EL HATTAOUI	Cardiologie
25	Pr. Mohamed AMINE	Médecine Communautaire (Médecine Préventive, santé publique et hygiène)
26	Pr. Noura TASSI	Maladies Infectieuses
27	Pr. Hicham NEJMI	Urgences-SAMU
28	Pr. Brahim ADMOU	Immunologie
29	Pr. Najat CHERIF IDRISSI EL GANOUNI	Radiologie

N°	NOM & PRENOM	SERVICE
30	Pr. Inass LAOUAD	Néphrologie
31	Pr. Ag. Mouna KHOUCHANI	Radiothérapie
32	Pr. Ag. Sanaa ZAOUI	Pharmacologie
33	Pr. Ag. Aboubakr MATRANE	Médecine nucléaire
34	Pr. Ag. Nisrine ABOUSSAIR	Génétique
35	Pr. Ag. Mustapha ALAOUI	Chirurgie vasculaire périphérique
36	Pr. Ag. Lamyae AMRO	Pneumophtisiologie
37	Pr. Ag. Yassine MSOUGAR	Chirurgie thoracique
38	Pr. Ag. Rhizlane BELBARAKA	Oncologie médicale

MARRAKECH

جامعة القاضي عياض

UNIVERSITÉ CADI AYYAD

كليـــــــة الـطب
و الصيدلة - مراكش

FACULTÉ DE MÉDECINE
ET DE PHARMACIE - MARRAKECH

Sidi Abaad -Assif,B .P 7010,
40000 Marrakech
Tél.: +212 5 24 33 98 98
Fax.: +212 5 24 43 28 87
Site web Faculté : www.fmpm.ucam.ac.ma
Site web Université : www.uca.ma